

Профилактика рефлюкс-эзофагита при гастрэктомии

Ельчибаев Б.М

Кафедра госпитальной хирургии

Семипалатинской государственной медицинской академии

УДК 616.33-006.6-089

Гастрэктомия кезіндегі рефлюкс-эзофагиттің алдын алу

Ельчибаев Б.М.

Асқазанның қатерлі ісгі әзірге дәрігерлік-әлеуметтік өзекті мәселелердің бірі болып, ғылыми зерттеулердің негізгі бағытын анықтаушы сала.

Оташылдық емнен кейінгі ерте және алыс кезеңдеріндегі асқынулары болдырмау немесе алдын алу мақсатында, өңеш пен ішек жалғауын құрау-дың тәсілі өзекті мәселе болып отыр.

Мақсаты - гастрэктомиядан кейінгі жақын және алыс кезеңдегі нәтижеле-рін жақсарту.

Асқазанның тұлғасы мен шеткерілік қатерлі ісігіне, өңешке таралмаған, шалдыққан 65 науқасқа оташылдық ем жасалынды.

Емдеу төмендегі жолмен жүргізілді – гастрэктомиямен лимфа бездерін сылынып алғаннан соң, ұлтабар тұқылы тігіледі. Көлденен тоқ ішектің шажырқайындағы саңлау арқылы, Трейтц байламынан 60 см қашықтықта жіңішке ішекті тұзақ арқылы өңешке тігіліп, бекіледі. Өңештің артқы қабырғасына жіңішке ішек бекінген соң, көк еттен 0,5-1,0 см қашықтықта өңеш пен ішекте саңлау жасалады. Жалғау бойы оралады. Ұсынылған өңеш-ішек жалғауы, гастрэктомиядан кейінгі өңеш-ішек жалғауының жарамсыздығын болдырмайды, сонымен қоса антирефлюкстік қасиеті басым, гастрэктомиядан кейінгі алыс кезеңдерінің нәтижелерін жақсартады.

Профилактика рефлюкс-эзофагита при гастрэктомии

Ельчибаев Б.М.

Рак желудка остается одной из наиболее важных медико-социальных проблем, определяющих стратегическое направление ведущих научных исследований.

Актуальной проблема является методики формирования пищеводно-кишечного соустья, которая позволит избежать или уменьшить число осложнений раннего и отдаленного послеоперационного периода.

Цель – улучшение ближайших и отдаленных результатов гастрэктомии.

Прооперировано 65 больных раком тела и проксимального отдела желудка без перехода опухолевого процесса на пищевод. Лечение осуществлялось следующим образом

Preventive maintenance a reflux-esophagitis after gastrectomy

Elchibaev B.M.

The stomach cancer remains to one of the most important problems defining a strategic direction of leading scientific researches.

Actual the problem is techniques of formation esophagointestinal anastomosis which will allow to avoid or reduce number of complications of the early and remote postoperative period.

The purpose – improvement of the nearest and remote results of gastrectomy.

65 patients with stomach body and upper third cancer without transition of tumor process was operated.

Treatment was carried out as follows – gastrectomy with lymph nodes dissections. Through a window of mesentery of transverse mesocolon in a duodenal stump the long loop of a lean gut on distance of 60 sm from a sheaf of Treitsa is made. After fixing of a loop of a small intestine, small intestine and gullet gleams on its back wall, offset 0,5-1 sm from diaphragms are opened. Then it is spent shroud the lines of generated anastomosis.

The offered way of formation esophagointestinal anastomosis in gastrectomy allows to exclude an inconsistency esophagus anastomosis which possesses expressed antireflux properties, considerably improving the remote results of the gastrectomy.

– производили гастрэктомию с лимфодиссекцией, культя 12-перстной кишки ушивалась. Через окно брызжеейки поперечно-ободочной кишки в культе пищевода производится длинная петля тощей кишки на расстоянии 60 см от связки Трейца. После фиксации петли тонкой кишки вскрываются просветы тонкой кишки и пищевода по его задней стенке, отступя 0,5-1 см от диафрагмы. Затем проводится окутывание линии сформированного анастомоза.

Предлагаемый способ формирования пищеводно-тонкокишечного анастомоза при гастрэктомии позволяет исключить несостоятельность пищеводного анастомоза, который обладает выраженным антирефлюксными свойствами, значительно улучшающий отдаленные результаты гастрэктомии.

Введение

Заболеваемость раком желудка по-прежнему сохраняет ведущее место в структуре онкологических заболеваний во всем мире. По статистическим данным в Республике Казахстан показатели заболеваемости раком желудка составляет 20,4 на 100000 населения и ежегодно регистрируется 3200 больных раком желудка, из них только 300 подвергаются радикальному хирургическому лечению, что составляет менее 10%. При этом пятилетняя общая выживаемость составила 18,7% [1]. Несмотря на многолетнее устойчивое снижение заболеваемости и смертности от РЖ, для многих стран, включая и Казахстан, это патология остается одной из наиболее важных медико-социальных проблем, определяющих стратегическое направление ведущих научных исследований. Улучшение ближайших и отдаленных результатов гастрэктомии остается весьма актуальной проблемой. Так, частота возникновения недостаточности швов пищеводно-кишечного анастомоза остается довольно высокой, и составляет 5–16,3% и более [2, 3, 4, 5]. Отмечено, что рефлюкс-эзофагит встречается у 8,2–95,3% оперированных больных, рубцовые стриктуры – в 6,5–22,4% наблюдений [6, 7, 8]. Возникая вследствие еюноэзофагеального рефлюкса, эзофагит существенно ухудшает результаты гастрэктомии. Медикаментозная терапия часто не дает стойкого положительного результата. Поэтому проблема разработки такой методики формирования пищеводно-кишечного соустья, которая позволит избежать или уменьшить число осложнений раннего и отдаленного послеоперационного, является актуальной.

Материал и методы

По разработанному нами способу пищеводно-тонкокишечного анастомоза за период 2003–2008 год в хирургических отделениях Медицинского центра СГМА, Семипалатинского ООД №2 и Республиканской соматической больницы Учреждения 156/15 гастрэктомия по поводу рака тела и проксимального отдела желудка без перехода опухолевого процесса на пищевод, была выполнена у 65 больных. Эффективность выполненной операции определяли как непосредственными результатами, так и функциональным состоянием пищеводно-тонкокишечного анастомоза.

Результаты и обсуждение

Возраст больных составил от 22 до 77 лет. Средний возраст наших пациентов составил 47,5 лет. Больных молодого возраста (до 50 лет) было 19 (29,2 %). Больных старшей возрастной группы было 46 (70,8)%. Среди 65 оперированных больных мужчин – 46 (70,8%), женщин – 19 (29,1%) . Преобладали пациенты мужского пола.

Лечение рефлюкс-эзофагита, это чрезвычайно сложная задача, поэтому наиболее актуален в настоящее время поиск методов их профилактики. По нашему мнению, решением данной проблемы является разработка модификации пластических приемов, применяемых для укрытия линии швов анастомоза. Успех объясняется тем, что просвет приводящего отдела тощей кишки полностью перекрывается резким перегибом петли кишки, образующий своеобразный заслон, препятствующий регургитации содержимого кишечника в просвет пищевода, обеспечивая профилактику анастомозита и эзофагита. Перечисленные выше требования легли в основу модифицированного и применяемого нами способа формирования пищеводно-тонкокишечного анастомоза.

Способ лечения осуществляется следующим образом. При установлении операбельности опухоли желудка после лапаротомии, производят гастрэктомию с объемами лимфодис-

секции D2-D3, культи двенадцатиперстной кишки ушивается.

Через окно брыжейки поперечно-ободочной кишки к культе пищевода подводится длинная петля тощей кишки на расстоянии 60 см от связки Трейца. После фиксации петли тонкой кишки 3 узловыми серозно-мышечными швами позади культи пищевода к диафрагме, вскрываются просветы тонкой кишки и пищевода по его задней стенке отступая на 0,5-1 см от диафрагмы. Затем накладываются однорядные узловые швы по четыре на заднюю и переднюю стенки с краевым захватом слизистой синтетической рассасывающейся нитью VYCRIL №3, завязывая узелки снаружки просвета анастомоза. Достоинством его является близкая к физиологическому шву адаптация сшиваемых слоев стенки пищеварительного тракта, сохранение хорошего кровоснабжения соединенных концов органа [4]. Затем проводится окутывание линии сформированного анастомоза, путем создания резкого перегиба приводящего отдела тонкой кишки в виде муфты, подшивая верхний край кишки узловыми швами к обнаженным краям диафрагмы у пищеводного отверстия. Отступая на 25 см от пищеводно-кишечного анастомоза между приводящей и отводящей петлями накладывается энтеро-энтероанастомоз, который фиксируется отдельными узловыми серо-серозными швами к краям разреза брыжейки поперечной ободочной кишки.

Ни в одном наблюдении после гастрэктомии, выполненной в нашей модификации, не отмечалось недостаточности швов пищеводно-кишечного анастомоза. Отсутствие этого грозного осложнения мы связываем формированием соустья на короткой культе (0,5-1 см) абдоминального отдела пищевода, обеспечивающий максимальную сохранность кровоснабжения и применением редких однорядных узловых прецизионных швов.

Продолжительность пребывания в стационаре после операции составила в среднем $13,4 \pm 2,6$ койко-дней.

Отслежены послеоперационные результаты от 3 месяцев до 5 лет. При обследовании пациентов применяли рентгенологическое и эндоскопическое исследование пищеводно-кишечного анастомоза, а также оценивали их общее клиническое состояние. Пациентов, не предъявляющих после операции жалоб диспептического характера и ликвидировавших дефицит массы тела в течение первого года, было 59 (90,8%). Их суточный пищевой рацион составляет 75-100% дооперационного объема при частоте питания от 3 до 5 раз в день. У 6 (9,2%) больных результаты оценены как удовлетворительные. У этих пациентов в разные сроки после операции отмечены: тяжесть в эпигастриальной области после приема пищи, демпинг-синдром легкой степени, не влияющий на активность больного, неоформленный стул до 5 раз в сутки. Дефицит массы тела у этих больных достигает на момент обследования около 10% дооперационной.

Всем пациентам в сроки 3, 6 месяцев, от 1 года до 5 лет после операции проводился рентгенологический контроль состояния пищеводно-кишечного соустья. При рентгеноскопии во всех наблюдениях пищеводно-кишечный анастомоз свободно проходим, поступление контрастной массы из пищевода в отводящую петлю тонкой кишки было порционным. Анастомоз раскрывался до 17-19 мм, смыкался полностью у 61 (95,3%) больных, у 4 (6,1%) полного смыкания анастомоза не наступало. При обследовании больных в положении Тренделенбурга частичный заброс контрастной массы в пищевод отмечен у 4 (6,1%) больных.

При эндоскопическом исследовании у 4 больных визуально выявлены признаки рефлюкс-эзофагита легкой степени. У всех пациентов анастомоз был свободно проходим для эндоскопа диаметром 11 мм.

При морфологическом исследовании биоптатов слизистой из дистального отдела пищевода в сроки от 1 года

до 5 лет после операции у 4 (6,1%) из обследованных больных отмечен катаральный рефлюкс-эзофагит, что проявлялось умеренной воспалительной инфильтрацией слизистого слоя нейтрофильными лейкоцитами и лимфоцитами, его отеком. Частота послеоперационного рефлюкс-эзофагита в отдаленные сроки после операции составила 6,1%. В остальных наблюдениях морфологическая картина слизистой пищевода соответствовал норме.

Выводы

1. Предлагаемый способ формирования пищеводно-тонкокишечного анастомоза при гастрэктомии позволяет исключить несостоятельность пищеводного анастомоза.
2. Анастомоз обладает выраженными антирефлюксными свойствами, значительно улучшающий отдаленные результаты гастрэктомии.

Литература

1. Арзыкулов Ж.А., Турекеев Б.А., Ижанов Е.Б. Современный стандарт лечения рака желудка // Мат. респ. научно - практич. семинара: «Совр. возм. клин. онкол.» –Астана, 2004.- С.181-184.
2. Шалимов А.А., Саенко В.Ф. Хирургия пищеварительного тракта издательство «Здоровье» Киев, 1987.
3. Щепотин И.Б., Эванс С.Р.Т. Рак желудка: практическое руководство по профилактике, диагностике и лечению. Киев 2000; -С.227.
4. Чибис О.А. и др. Основы теории и практики желудочно-кишечного шва. М., Издательство Университета дружбы народов, 1988,-С.10.
5. Жерлов Г.К., Зыков Д.В. Арефлюксные анастомозы в хирургии рака желудка. Томск 1996, -С. 172.
6. Иванов М.А. Сравнительная оценка вариантов пищеводно-кишечных анастомозов и возможности коррекции функциональных нарушений кишечника при гастрэктомии: Автореф. Дис. д-ра мед. наук. М.1999.
7. Давыдов М.И., Тер-Ованесов М.Д. Современная стратегия хирургического лечения рака желудка. Том 2. №1.2000. –С. 1-14.